ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.7—2008

针灸技术操作规范
第7部分:皮肤针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 7:Skin needle

2008-04-23 发布 2008-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；
——第2部分：头针；
——第3部分：耳针；
——第4部分：三棱针；
——第5部分：拔罐；
——第6部分：穴位注射；
——第7部分：皮肤针；
——第8部分：皮内针；
——第9部分：穴位贴敷；
——第10部分：穴位埋线；
——第11部分：电针；
——第12部分：火针；
——第13部分：芒针；
——第14部分：鍉体；
——第15部分：眼针；
——第16部分：鼻针；
——第17部分：口唇针；
——第18部分：腹针；
——第19部分：腕踝针；
——第20部分：毫针基本刺法；
——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第7部分。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分起草单位：湖北中医学院。

本部分主要起草人：王华、陈邦国、吴绪平、梁凤霞、曾晓玲、王述菊。

针灸技术操作规范
第7部分:皮肤针

1 范围

GB/T 21709的本部分规定了皮肤针的术语和定义、操作步骤与要求、操作方法、注意事项与禁忌。本部分适用于皮肤针技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 21709的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 21709.5 针灸技术操作规范 第5部分:拔罐

3 术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

3.1

皮肤针 skin needle

由多支不锈钢短针集成一束,或均匀镶嵌在如莲蓬形的针盘上,固定在针柄的一端而成的针具。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 针具选择

根据病情需要和操作部位的不同,选择不同类型的皮肤针。应选择针身光滑、无锈蚀,针尖锐利、无倒钩,针柄牢固、无松动的皮肤针。

4.1.2 施术部位选择

应根据病症选取适当的部位。

4.1.3 患者体位选择

应选择患者舒适、医者便于操作的治疗体位。

4.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

4.1.5 消毒

4.1.5.1 针具消毒

应选择高压消毒法。宜选择一次性皮肤针。

4.1.5.2 部位消毒

用75%乙醇或0.5%碘伏棉球在施术部位消毒。强刺激部位宜用0.5%碘伏棉球消毒。

4.1.5.3 术者消毒

医者双手应用肥皂水清洗干净,再用75%乙醇棉球擦拭。

4.2 施术方法

4.2.1 持针姿势

4.2.1.1 软柄皮肤针

将针柄末端置于掌心，拇指居上，食指在下，其余手指呈握拳状握住针柄末端。

4.2.1.2 硬柄皮肤针

用拇指和中指夹持针柄两侧，食指置于针柄中段的上面，无名指和小指将针柄末端固定于大小鱼际之间。

4.2.2 叩刺方法

针尖对准叩刺部位，运用灵活的腕力垂直叩刺，即将针尖垂直叩击在皮肤上，并立即弹起，如此反复进行。

4.2.3 刺激强度

4.2.3.1 弱刺激

用较轻的腕力叩刺，局部皮肤略见潮红，患者稍有疼痛感觉。

4.2.3.2 中等刺激

叩刺的腕力介于弱、强刺激之间，局部皮肤明显潮红，微渗血，患者有疼痛感。

4.2.3.3 强刺激

用较重的腕力叩刺，局部皮肤明显潮红，可见出血，患者有明显疼痛感觉。

4.2.4 叩刺部位

4.2.4.1 穴位叩刺

选取与疾病相关的穴位叩刺。主要用于背俞穴、夹脊穴、某些特定穴和阳性反应点。

4.2.4.2 局部叩刺

在病变局部叩刺。主要用于病变局部。

4.2.4.3 循经叩刺

沿着与疾病有关的经脉循行路线叩刺。主要用于项、背、腰、骶部的督脉和足太阳膀胱经，其次是四肢肘、膝以下的三阴经、三阳经。

4.3 施术后处理

叩刺后皮肤如有出血，须用消毒干棉球擦拭干净，保持清洁，以防感染。

5 注意事项

5.1 叩刺时针尖与皮肤应垂直，用力均匀，避免斜刺或钩挑，以减轻疼痛。

5.2 皮肤针治疗后，可配合拔罐疗法，拔罐的技术操作规范见 GB/T 21709.5。

5.3 皮肤针治疗间隔时间，参见第 A.1 章。

5.4 注意晕针的预防和处理。患者采取卧位可预防晕针；如发生晕针现象，处理办法参见第 A.2 章。

5.5 患者精神紧张、大汗后、劳累后或饥饿时不宜运用本疗法。

5.6 皮肤局部有感染、溃疡、创伤、瘢痕时不宜运用本疗法。

5.7 医者勿接触患者所出血液。治疗过程中出血较多时，患者要适当休息后才能离开。

6 禁忌

6.1 急性传染性疾病患者。

6.2 凝血功能障碍性疾病患者。

附　录　A
（资料性附录）
皮肤针治疗间隔时间、操作意外的处理方法

A.1　皮肤针治疗间隔时间

皮肤针治疗间隔时间根据病情需要而定，弱刺激和中等刺激治疗时，可 1 次/d 或 2 次/d；强刺激治疗时，可 1 次/d 或隔日 1 次。

A.2　皮肤针操作意外的处理方法

若发生晕针应立即停止叩刺，使患者呈头低脚高卧位，注意保暖，必要时可饮用温开水或温糖水，或掐按水沟、内关等穴，即可恢复。严重时按晕厥处理。